

Douleur au tibia

La périostite tibiale

*Le plan simple pour soulager la périostite
sans arrêter de courir.*



Maxence Lecointe

Ostéopathe D.O. — Expert Running — Lille

Introduction

Pourquoi ce guide ?

Si vous lisez ce guide, c'est probablement parce que votre tibia vous freine dans la pratique de la course à pied.

Peut-être que la douleur apparaît dès les premières minutes de course.

Peut-être qu'elle s'atténue un peu en courant, pour mieux revenir après.

Peut-être que vous avez déjà essayé le repos, la glace, des semelles.

Et peut-être que vous avez surtout envie d'une chose : courir sereinement.

Qui suis-je ?

Je suis ostéopathe depuis 2015, installé à Lille depuis le début de mon activité. J'ai progressivement orienté ma pratique vers la prise en charge du coureur.

Au fil des années, j'ai accompagné des coureurs débutants, des sportifs en reprise après blessure, des athlètes préparant semi-marathon, marathon ou ultra, ainsi que des profils « sport santé » souhaitant simplement courir sans douleur.

Très vite, une évidence s'est imposée : la majorité des douleurs du coureur ne relèvent pas uniquement d'un trouble local. Elles relèvent souvent d'un déséquilibre entre la charge d'entraînement, la capacité tissulaire, la progression et la récupération.

Ma prise en charge du coureur : une approche globale

Au cabinet, mon accompagnement repose sur cinq piliers :

1. Analyse clinique et compréhension du contexte (historique de blessure, volume d'entraînement, progression récente, objectifs).
2. Évaluation de la charge (répartition hebdomadaire, intensité, variations brutales).
3. Analyse de foulée (observation sur tapis, compréhension des contraintes biomécaniques, mise en perspective sans sur-interprétation).
4. Renforcement ciblé et progressif (travail de capacité musculaire et de tolérance mécanique).
5. Planification du retour à la course (réintroduction structurée des volumes et intensités).

Ce guide est directement inspiré de cette méthodologie. Il ne remplace pas l'accompagnement individualisé, mais il en reprend la logique.

Avez-vous le bon guide ?

Avant de continuer, prenez 2 minutes pour vérifier que ce guide correspond bien à votre situation. Cochez mentalement les affirmations qui vous ressemblent.

Auto-diagnostic en 6 questions

- Ma douleur se situe le long de la face interne du tibia (tiers inférieur ou moyen).
- Elle est diffuse — pas localisée sur un point unique très précis.
- Elle apparaît en début de sortie, parfois s'atténue en courant, puis revient après l'effort.
- Elle est apparue après une augmentation de volume, d'intensité, ou un changement de terrain (route, sentier, piste).
- Le repos seul a déjà été essayé, sans résolution durable.
- Je peux encore courir, ou je veux pouvoir continuer à courir intelligemment.

Si vous cochez 4 affirmations sur 6

Ce guide est probablement adapté à votre situation. La méthode présentée vous donnera un cadre clair pour gérer la douleur, structurer votre reprise, et continuer à courir sans aggraver.

Si la douleur est très localisée sur un point précis du tibia

Ce guide n'est pas adapté en première intention. Une douleur ponctuelle, intense, surtout si elle empire à chaque sortie, peut évoquer une fracture de fatigue. Consultez avant d'appliquer ce plan.

Drapeaux rouges : quand consulter sans attendre

La méthode présentée ici suppose une périostite tibiale (syndrome de stress tibial médial) « classique ». Certains signes orientent vers d'autres pathologies — en particulier la fracture de fatigue — qui nécessitent une évaluation médicale avant toute reprise structurée.

⚠️ **CONSULTEZ SANS ATTENDRE SI :**

- Douleur très localisée sur un point précis du tibia (vs douleur diffuse sur une zone allongée).
- Douleur nocturne ou présente au repos prolongé.
- Douleur qui empire à chaque sortie malgré le repos.
- Gonflement visible le long du tibia ou tibia chaud au toucher.
- Douleur reproductible par sautilllements sur un pied (test simple à faire chez soi).
- Antécédent de troubles du cycle menstruel, de carences alimentaires ou de perte de poids récente (facteurs de risque osseux).
- Fièvre associée à la douleur du tibia.

Dans tous ces cas, ce guide ne suffit pas. Consultez votre médecin traitant ou un médecin du sport pour exclure une fracture de fatigue avant de reprendre. Une simple radiographie ne suffit souvent pas — une scintigraphie ou une IRM peut être nécessaire.

Ce que ce guide est, ce qu'il n'est pas

Ce guide est :

- Une base structurée et adaptable.
- Un cadre de progression sur 8 semaines.
- Une synthèse de principes éprouvés en cabinet.
- Un outil pour reprendre le contrôle de votre pratique.

Ce guide n'est pas :

- Un diagnostic médical personnalisé.
- Un protocole universel applicable à tous.
- Un substitut à une consultation.

Chaque coureur est unique. L'âge, l'historique sportif, la morphologie, la charge d'entraînement et les objectifs influencent la prise en charge. Si vous avez un doute, consultez.

À qui s'adresse ce plan ?

Vous êtes au bon endroit si :

- Vous ressentez une douleur diffuse le long du tibia à la course.
- Vous continuez à courir, ou vous voulez continuer.
- Le repos seul n'a rien réglé durablement.
- Vous êtes perdu(e) entre des conseils contradictoires.

Ce guide n'est PAS fait pour vous si :

- Vous suspectez une fracture de fatigue (consultez d'abord).
- Vous cherchez un diagnostic médical précis.
- Vous refusez d'adapter temporairement votre entraînement.

Principes du plan

10 à 15 minutes par séance. 3 séances par semaine. Sur 8 semaines. En continuant à courir intelligemment.

Partie 1 — Pourquoi ça fait mal et pourquoi ça dure ?

1. Cette douleur est fréquente chez le coureur

La périostite tibiale (ou syndrome de stress tibial médial) se manifeste généralement le long de la face interne du tibia (tiers inférieur ou moyen), en début de sortie avec parfois une atténuation en courant, à la fin ou après l'effort, et après une augmentation de volume, d'intensité, ou un changement de terrain.

Bonne nouvelle

Dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas d'un tibia « abîmé ». Il s'agit d'un périoste dépassé par la charge qu'on lui impose.

2. La vraie cause : un problème de tolérance à la charge osseuse

Votre tibia supporte des milliers d'impacts à chaque sortie.

Le problème n'est pas le mouvement en lui-même. Le problème n'est pas forcément votre foulée. Le problème n'est pas un tibia « trop fragile ».

Le problème, c'est un déséquilibre entre :

- la charge imposée (volume, intensité, terrain, surface),
- la capacité actuelle du périoste et des muscles à la supporter.

Quand la charge dépasse la capacité, la douleur apparaît. Si on baisse un peu la charge et qu'on augmente progressivement la capacité, la douleur diminue.

Particularité de l'os

Le périoste s'adapte plus lentement que les muscles ou les tendons. Une progression de + 10 % par semaine est souvent déjà trop en début de pratique. C'est pour cela que ce plan dure 8 semaines (vs 6 pour les pathologies articulaires ou tendineuses légères).

3. Pourquoi le repos seul ne règle pas le problème

Beaucoup de coureurs font ceci : douleur → arrêt complet → reprise identique → retour de la douleur.

Le repos diminue l'irritation, mais il ne renforce pas la capacité du tibia à encaisser la charge. Résultat : le coureur repart avec la même tolérance qu'avant.

Le but n'est pas d'éviter toute contrainte. Le but est de réadapter progressivement le tibia à la contrainte.

4. Douleur ne signifie pas fracture

Une douleur diffuse à 2 ou 3/10 le long du tibia ne signifie pas que vous êtes en train de fracasser votre os.

La douleur est souvent un signal de sensibilité accrue du périoste, pas une alarme de destruction. Elle reflète une surcharge mécanique, pas nécessairement une fracture.

Mais — et c'est important — certains signes doivent faire évoquer une fracture de fatigue (voir page « Drapeaux rouges »).

5. Les erreurs les plus fréquentes

1. Augmenter le volume trop vite

Le périoste s'adapte plus lentement que les muscles. + 10 % par semaine est souvent déjà trop en début de pratique.

2. Tout arrêter brutalement

Cela réduit temporairement la douleur, mais aussi la tolérance. La reprise identique ramène la douleur.

3. Ignorer la raideur matinale

La douleur au lever ou en début de marche est un signal que la charge de la veille était excessive.

4. Changer trop de variables en même temps

Chaussures + terrain + volume + exercices : impossible de savoir ce qui fonctionne.

Partie 2 — Les règles pour progresser sans aggraver

Avant de commencer le plan d'exercices, il est essentiel de comprendre une chose :

Principe fondamental

Ce n'est pas l'exercice qui guérit. C'est la cohérence dans la gestion de la charge. En respectant ces règles, le tibia progresse. En les ignorant, la douleur revient.

1. La règle de la douleur tolérable

Pendant les exercices ou la course, une gêne légère est acceptable. Une douleur $\leq 3/10$ est généralement tolérable.

On ne veut pas :

- Une douleur qui augmente fortement pendant la séance.
- Une douleur qui explose le lendemain.
- Une douleur qui apparaît au repos après l'effort.

Douleur (échelle 0-10)	Conduite à tenir
0–3	Zone acceptable. On continue.
4–6	Prudence. Réduire le volume / l'intensité de la séance.
7+	Stop ou adaptation forte nécessaire.

2. Une seule variable à la fois

Quand l'entraînement évolue, on ne change qu'un seul paramètre : volume, intensité, terrain, fréquence ou type de séance.

On ne change pas chaussures + terrain + volume + exercices en même temps.

3. Pas de double progression

On ne peut pas augmenter le volume de course ET la difficulté du renforcement au même moment. On choisit l'un ou l'autre. Priorité : stabiliser la douleur, puis progresser progressivement.

4. La règle des 20 %

Si la douleur augmente :

- On réduit le volume hebdomadaire d'environ 20 % de manière temporaire (7 à 14 jours).
- On garde une intensité modérée.
- On supprime temporairement les séances les plus agressives (piste, fractionné intense, descentes).

Inutile d'arrêter totalement. Il suffit souvent d'ajuster.

5. La constance prime sur l'intensité

Ce plan fonctionne en étant régulier, patient, cohérent. Le corps s'adapte à ce qui est répété, pas aux séances ponctuelles.

6. Surveiller les bons indicateurs

Ne pas se focaliser uniquement sur la douleur. Observer aussi :

- La durée avant apparition de la gêne.
- La raideur matinale du tibia (premier pas au lever).
- La récupération le lendemain.
- La distance parcourue sans douleur.
- La confiance à la course.

7. Le principe fondamental

On ne cherche pas à supprimer toute contrainte. On cherche à rendre le tibia plus tolérant à la contrainte.

La progression n'est pas linéaire. Il y aura parfois des jours « avec » et des jours « sans ». Ce qui compte, c'est la tendance sur plusieurs semaines.

À retenir

Une douleur légère contrôlée est acceptable. Une seule variable progresse à la fois. Si la douleur augmente, on ajuste — on ne panique pas. La régularité prime sur l'intensité. La raideur matinale est un signal : ajustez la charge.

Partie 3 — Le plan anti-douleur sur 8 semaines

Pourquoi 8 semaines ? Parce que le périoste et l'os sous-jacent ont besoin d'environ 6 à 10 semaines pour augmenter significativement leur tolérance à la charge mécanique. C'est plus long que les tissus mous (muscles, tendons légers). Aller plus vite ne sert à rien et peut entretenir la blessure.

Avant de commencer

- 10 à 15 minutes par séance.
- 3 fois par semaine.
- Idéalement les jours sans séance de course intense.
- Objectif : augmenter la tolérance du tibia à la charge.

Respecter les règles de la Partie 2 (douleur $\leq 3/10$ à tout moment). Les exercices ne sont pas douloureux par nature. Si la douleur dépasse 3/10, réduisez l'amplitude ou le nombre de répétitions.

Exercice 1 — Élévations de talons bilatérales

Objectif : renforcer le soléaire et les gastrocnémiens, principaux muscles absorbeurs des chocs tibiaux. C'est la base de toute rééducation de la périostite — le mollet est l'amortisseur naturel du tibia.



Position basse



Position haute

Mise en place

- Debout (au sol ou sur une marche), pieds parallèles, largeur du bassin.
- Mains sur un mur ou un dossier de chaise pour l'équilibre.

Exécution

- Monter sur la pointe des pieds lentement (2 secondes).
- Tenir 1 à 2 secondes en haut.
- Descendre lentement (3 secondes) — la descente est la phase clé.

Erreurs fréquentes

- Descendre trop vite (perte du bénéfice excentrique).
- Compenser avec les orteils plutôt que les mollets.
- Ne pas monter suffisamment haut.

Progression

Semaines	Séries	Répétitions	Tempo (montée / descente)
1–2	3	12	2 s / 3 s
3–4	3	15	2 s / 3 s
5–6	3	18	2 s / 4 s
7–8	3	20	2 s / 4 s

Si trop facile : ralentir encore la descente. Si douleur > 3/10 : réduire les répétitions.

Exercice 2 — Élévations de talons unilatérales

Objectif : augmenter la charge sur chaque jambe individuellement. Simule mieux les contraintes de la course. À introduire progressivement à partir de la semaine 3.



Position basse



Position haute

Mise en place

- Debout sur un pied (au sol ou sur une marche), autre pied légèrement soulevé.
- Main sur un appui pour la sécurité.

Exécution

- Monter sur la pointe du pied (2 secondes).
- Descendre lentement en contrôlant (3 à 4 secondes).
- Ne pas laisser le talon claquer au sol.

Erreurs fréquentes

- Compenser avec la jambe au repos.
- Descente trop rapide.
- Commencer cette variante trop tôt (avant la semaine 3).

Progression

Semaines	Séries	Répétitions	Note
1–2	—	—	Exercice 1 uniquement (bilatéral)
3–4	3	8 / côté	Si douleur : revenir ex. 1
5–6	3	10 / côté	Tempo : 2 s / 4 s
7–8	3	12 / côté	Tempo : 2 s / 4 s

Exercice 3 — Renforcement du tibial postérieur

Objectif : renforcer le tibial postérieur, muscle clé du contrôle de la pronation et de l'arche plantaire. Souvent négligé, il joue un rôle direct dans la surcharge tibiale chez le coureur.



Renforcement tibial postérieur

Mise en place

- Assis sur une chaise, pied posé à plat au sol.
- Élastique autour du pied, fixé à un pied de chaise du côté opposé.

Exécution

- Tourner la pointe du pied vers l'intérieur contre la résistance de l'élastique.
- Contrôler le retour lentement (ne pas lâcher brusquement).
- Amplitude confortable, pas forcée.

Erreurs fréquentes

- Utiliser la hanche au lieu du pied.
- Amplitude trop grande.
- Retour non contrôlé.

Progression

Semaines	Séries	Répétitions
1–2	3	15
3–4	3	18
5–6	3	20
7–8	4	20

Augmenter progressivement la résistance de l'élastique au fil des semaines.

Exercice 4 — Marche sur les talons / Flexion dorsale active

Objectif : renforcer le jambier antérieur (tibial antérieur) et augmenter la tolérance directe du tibia à la contrainte en charge. Deux variantes possibles selon votre matériel.



Variante A — Marche sur les talons



Variante B — Flexion dorsale

Variante A — Marche sur les talons

- Marchez 15 à 20 mètres sur les talons, pointes levées.
- Dos droit, pas de compensation du tronc.
- 2 à 3 allers-retours.

Variante B — Flexion dorsale avec élastique

- Assis, pied dans le vide ou légèrement posé.
- Élastique autour du dessus du pied, résistance vers le bas.
- Ramener la pointe du pied vers soi contre la résistance.
- Contrôler lentement le retour.

Erreurs fréquentes

- Aller trop vite lors de la marche.
- Amplitude insuffisante en flexion dorsale.

Progression

Semaines	Variante A — Marche	Variante B — Élastique
1–2	2 × 15 m	3 × 15 rép.
3–4	3 × 15 m	3 × 18 rép.
5–6	3 × 20 m	3 × 20 rép.
7–8	4 × 20 m	4 × 20 rép.

Récapitulatif du plan complet

	Ex. 1 — Bilatéral	Ex. 2 — Unilatéral	Ex. 3 — Tibial post.	Ex. 4 — Talon / FD
Sem. 1–2	3 × 12	—	3 × 15	2 × 15 m / 3 × 15
Sem. 3–4	3 × 15	3 × 8	3 × 18	3 × 15 m / 3 × 18
Sem. 5–6	3 × 18	3 × 10	3 × 20	3 × 20 m / 3 × 20
Sem. 7–8	3 × 20	3 × 12	4 × 20	4 × 20 m / 4 × 20

3 séances par semaine — 10 à 15 minutes — douleur ≤ 3/10 à tout moment.

La course pendant les 8 semaines

La course n'est pas interdite. L'objectif est de la pratiquer intelligemment, en respectant la fenêtre de tolérance du tibia.

Semaines 1–2 : stabilisation

Réduire le volume de ~ 20 %. Pas de fractionné. Terrain souple privilégié (chemins, sentiers).

Semaines 3–4 : reprise progressive

Réintroduire doucement le volume. Une seule augmentation à la fois (pas volume + intensité ensemble).

Semaines 5–6 : consolidation

Volume proche de la normale. Introduction prudente des séances d'intensité modérée.

Semaines 7–8 : progression

Retour à votre pratique habituelle si les indicateurs sont bons (pas de douleur, récupération correcte, pas de raideur matinale).

Conclusion : reconstruire pour durer

La périostite tibiale n'est pas une fatalité. Elle est le signe que votre tibia a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la charge que vous lui demandez.

La solution n'était pas d'arrêter définitivement. Ni de forcer. Ni de chercher un exercice miracle.

La solution était de comprendre, structurer, progresser.

Vous disposez maintenant :

- D'une compréhension claire de la périostite tibiale.
- Des règles pour éviter d'entretenir la douleur.
- D'un plan d'exercices progressif sur 8 semaines.
- D'une stratégie pour continuer à courir intelligemment.

Ce n'est pas un protocole figé. C'est un cadre adaptable.

Ce qui fera la différence

La régularité et la patience. Pas la perfection. Le tibia est un tissu lent : il faut lui laisser le temps de s'adapter. Deux à quatre séances de renforcement par semaine, une gestion intelligente de la charge — c'est ainsi que la capacité revient.

Une vérité importante

La douleur peut fluctuer. Un jour meilleur, un jour plus sensible. Ce n'est pas un échec. C'est le processus d'adaptation.

L'objectif n'est pas zéro sensation. L'objectif est une capacité durable.

Pour aller plus loin



Mot de l'auteur

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez décidé de ne plus subir. Et c'est déjà un premier pas important.

La douleur tibiale peut être frustrante. Elle freine l'élan, elle fait douter, elle oblige à ralentir. Mais elle n'est pas une fatalité.

Dans mon activité d'ostéopathe, j'ai vu de nombreux coureurs passer par cette phase. Certains étaient débutants en pleine progression, d'autres préparaient un marathon. Tous avaient en commun la même question : « est-ce que je vais pouvoir recourir normalement ? »

La réponse est souvent oui — à condition d'une méthode et d'un peu de patience.

Pour un bilan personnalisé

→ **Réservez votre rendez-vous en cabinet à Lille**

Pour un bilan personnalisé : analyse de foulée, évaluation de la charge, plan de reprise individualisé.

doctolib.fr/osteopathe/lille/maxence-lecointe

Cabinet : 40 rue Royale, 59800 Lille.

Témoignage

Clément

« Pratiquant le trail (et la course à pied en général) et ayant parfois des douleurs articulaires ou tendineuses, j'ai été très bien traité par Maxence Lecointe.

C'est un sportif qui a suivi une spécialisation dans la course à pied, il maîtrise son sujet et donne de bons conseils pour muscler/tonifier, adapter sa charge physique à son corps et ses douleurs, etc. » — Clément, 37 ans.

Me contacter

- Cabinet : 40 rue Royale, 59800 Lille.
- Itinéraire : maps.app.goo.gl/REedwh2ijmQuvf5C8
- Prise de rendez-vous : doctolib.fr/osteopathe/lille/maxence-lecointe

En cadeau : votre check-list de reprise

Pour vous accompagner au-delà de ce guide, je vous offre une check-list imprimable d'une page à glisser dans votre carnet d'entraînement. Elle reprend les indicateurs à surveiller chaque semaine pour ajuster votre progression.

□ [Télécharger ma check-list gratuite \(PDF\)](#)

Bon courage, et bonne course.